

①

細胞障害性抗がん薬

分類・作用機序・臓器毒性

1 薬剤の分類マップ

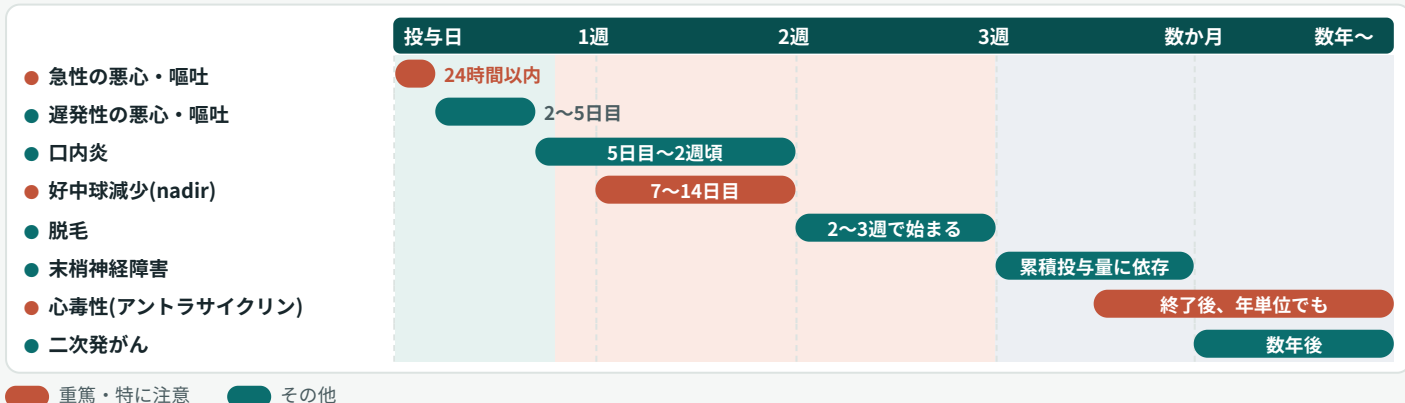
DNAに作用 DNAを架橋して複製を阻害	アルキル化薬 シクロホスファミド イホスファミド ベンダムスチン テモゾロミド 白金製剤 シスプラチン カルボプラチン オキサリプラチン
代謝拮抗薬 偽の材料でDNA合成を停止	葉酸代謝拮抗薬 メトトレキサート ベメトレキセド ピリミジン代謝拮抗薬 5-FU S-1 カベシタビン ゲムシタビン プリン代謝拮抗薬 メルカプトプリン フルダラビン
微小管阻害薬 細胞分裂(M期)を停止	タキサン系 パクリタキセル ドセタキセル nab-パクリタキセル ビンカアルカロイド系 ビンクリスチン ビノレルビン その他 エリブリン
トポ阻害薬 DNAの切断・再結合を阻害	トポイソメラーゼⅠ型 イリノテカン ノゲテカン トポイソメラーゼⅡ型 エトポシド
抗腫瘍性抗生物質 DNAに入り込み複製を阻害	アントラサイクリン系 ドキソルビシン エピルビシン アムルビシン その他 ブレオマイシン マイトマイシンC

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 臓器に特有の毒性と予防・対策

臓器毒性	主な原因薬剤	病院での予防・対策	薬局で確認すること
心毒性	ドキソルビシン等のアントラサイクリン系(累積投与量に依存)	累積投与量の管理、治療前後の心エコー	息切れ・むくみ・急な体重増加、抗HER2療法の併用歴
腎障害	シスプラチン、大量メトトレキサート	大量補液・Mg補充/尿のアルカリ化・ホリナート救援	処方箋の検査値でクレアチニン、NSAIDs・PPIの併用、水分摂取
出血性膀胱炎	イホスファミド、大量シクロホスファミド	メスナの併用、補液	血尿・排尿時の痛み、1日の水分摂取量
肺毒性	ブレオマイシン(総投与量に依存)	総投与量の管理、呼吸機能の確認	咳・息切れ・発熱が続かないか
末梢神経障害	タキサン系、ビンカアルカロイド系、オキサリプラチン	減量・休薬の判断	ボタン・箸・歩行など具体的な動作での変化
血管外漏出	アントラサイクリン系、ビンカアルカロイド系	投与中の観察、漏出時の処置	帰宅後の点滴部位の痛み・赤み・腫れ

3 副作用の特徴と発現時期



押さえておきたいポイント

- 5つのグループと細胞周期上の作用点で整理すると、効き方と副作用が理解しやすい
- 臓器特有の毒性は、病院での累積投与量・腎機能の確認と、薬局での症状の聞き取りの両面で管理
- レジメン・検査値・副作用Grade・服用状況を病院と薬局で共有することが、安全な治療継続の鍵